

Multipl Skleroz (MS)

Multipl Skleroz (MS), merkezi sinir sistemini yani beyin ve omuriliği etkileyen, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kendi sinir dokularına saldırmasıyla ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Bağışıklık sisteminin saldırdığı temel yapı, sinirleri çevreleyen miyelin kılıftır. Miyelin, sinirler arasındaki iletişimin düzgün gerçekleşmesine yardımcı olur. Bu yapının zarar görmesiyle beyin ile vücudun diğer bölümleri arasındaki iletişim aksayabilir. Bu nedenle MS, kişiden kişiye farklı belirtilerle kendini gösterebilir.

MS özellikle genç yetişkinlerde görülür ve kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanır. Dünya genelinde 1,8 milyondan fazla kişinin MS ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Hastalığın nasıl seyredeceği ise herkes için aynı değildir. Bazı kişilerde belirtiler ortaya çıktıktan sonra tamamen veya kısmen düzelebilirken, bazı kişilerde zaman içinde belirtiler kalıcı hale gelebilir. Bu nedenle MS'i tek bir şekilde ilerleyen bir hastalık olarak düşünmek doğru değildir.

Miyelin kılıfının zarar görmesi, sinirlerden gönderilen mesajların iletimini bozabilir. Bunun sonucunda görme sorunları, uyuşma, kas güçsüzlüğü, denge ve yürüme problemleri, kas sertliği ve yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bunun yanında mesane kontrolüyle ilgili sorunlar, baş dönmesi, konuşma güçlüğü, depresyon ve dikkat, hafıza veya düşünme gibi bilişsel alanlarda değişiklikler de görülebilir. Ancak önemli olan nokta, her MS hastasında bütün bu belirtilerin görülmemesidir. Belirtiler, beynin veya omuriliğin hangi bölgesinin etkilendiğine göre değişebilir.

MS'in en sık görülen seyirlerinden biri ataklarla seyreden MS'tir. Bu durumda belirli dönemlerde yeni belirtiler ortaya çıkar ve ardından belirtilerin tamamen veya kısmen düzeldiği dönemler yaşanabilir. Bazı kişilerde ise hastalık zaman içinde daha sürekli bir ilerleme gösterebilir. Primer ilerleyici MS'te belirtiler başlangıçtan itibaren yavaş yavaş kötüleşirken, sekonder ilerleyici MS'te başlangıçta ataklarla seyreden hastalık daha sonra sürekli ilerleyen bir hale gelebilir.

MS'in kesin nedeni henüz bilinmemektedir. Ancak genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı düşünülmektedir. Ailede MS bulunması hastalığa yatkınlığı artırabilir, fakat MS doğrudan kalıtsal bir hastalık olarak kabul edilmez. Araştırmalarda Epstein-Barr virüsü, güneş ışığı ve D vitamini düzeyleri gibi çeşitli faktörlerle MS arasında ilişkiler bulunmuştur. Sigara kullanımının da MS gelişme olasılığı ve hastalığın daha ağır seyretmesiyle ilişkili olduğu bildirilmiştir.

MS'i kesin olarak gösteren tek bir test yoktur. Tanı için kişinin belirtileri ve nörolojik muayenesi değerlendirilir; bunun yanında özellikle manyetik rezonans görüntüleme (MR) kullanılır. MR görüntülerinde MS ile ilişkili lezyonlar görülebilir. Gerekliğinde beyin

omurilik sıvısının incelenmesi, uyarılmış potansiyel testleri ve optik koherens tomografi gibi başka testlerden de yararlanılabilir.

MS'in bugün için kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak hastalığın kontrol altına alınması için etkili tedaviler vardır. Tedavinin temel amaçları atakları azaltmak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve belirtileri kontrol etmektir. Atak dönemlerinde kortikosteroidler kullanılabilir. Hastalığın seyrini değiştiren tedaviler ise yeni atakların ve hastalık aktivitesinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bunun yanında fizik tedavi ve rehabilitasyon, hareket kabiliyetinin korunmasına ve günlük yaşamın kolaylaştırılmasına destek olabilir.

MS konusunda dikkat çeken bir diğer nokta ise hastalığın bazı kişilerde daha belirtiler ortaya çıkmadan önce MR görüntülerinde kendini gösterebilmesidir. Radyolojik olarak izole sendrom (RIS) adı verilen bu durumda kişide MS'i düşündüren MR bulguları bulunurken henüz belirgin MS belirtileri görülmebilir. 2025 yılında yayımlanan geniş bir çalışmada, RIS tanısı alan 273 kişinin yaklaşık üçte birinde takip sürecinde MS belirtilerinin geliştiği ve bazı biyobelirteçlerin bu riski öngörmede yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Bu bulgular, hastalığın erken dönemde fark edilmesi ve risk taşıyan kişilerin daha yakından

takip edilmesi açısından önem taşımaktadır.

Sonuç olarak MS, bağışıklık sisteminin merkezi sinir sistemindeki miyeline zarar vermesiyle ortaya çıkan ve kişiden kişiye farklılık gösterebilen bir hastalıktır. Görme sorunlarından yorgunluğa, uyuşmadan denge problemlerine kadar çok farklı belirtilere neden olabilir. Her MS hastasının hastalığı aynı şekilde ilerlemez. Günümüzde kesin bir tedavisi olmasa da erken tanı, uygun tedavi ve rehabilitasyon ile hastalığın kontrol altında tutulması ve yaşam kalitesinin korunması mümkündür.

Kaynaklar:

- 1) World Health Organization. (2023, August 7). *Multiple sclerosis*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/multiple-sclerosis>
- 2) Acıbadem Sağlık Grubu. (2025, June 20). *Multiple Skleroz (MS)*. <https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/multiple-skleroz-ms/>
- 3) National Institute of Neurological Disorders and Stroke. *Multiple Sclerosis (MS)*. National Institutes of Health. <https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/multiple-sclerosis-ms>
- 4) Fissolo N, et al. Prognostic Factors for Multiple Sclerosis Symptoms in Radiologically Isolated Syndrome. *JAMA Neurol*. 2025 Jul 1;82(7):722-733. doi:10.1001/jamaneurol.2025.1481. PMID: 40455494. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40455494/>

Ali Bocakkıtaç/ Founder, Wionpav Labs/ Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University